O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

MA’RUZA MATNI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

N-4: Ko‘z qovoqlari, ko‘z yoshi yo‘llari va shilliq qavat yallig‘lanish kasalliklarida hamshiralik ishi

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Nazariy mashg‘ulot, 2 soat (80 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

Mashg‘ulot maqsadi

O‘quvchilarda ko‘z qovoqlari, ko‘z yoshi yo‘llari va shilliq parda yallig‘lanish kasalliklarining sabablari, belgilari, davolash va oldini olish hamda ularda hamshiralik parvarishi to‘g‘risida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish.

Reja

1. Ko‘z qovoqlari kasalliklari
2. Dakrioadenit va dakriotsistit: sabablari, klinikasi, davolash
3. Kon’yunktivitlar: sabablari, turlari, belgilari va oldini olish

O‘qitish natijalari (o‘quvchi mashg‘ulot yakunida):

- Govmichcha, blefarit, xalazion va qovoq abssessining sabablari, davolash usullarini aytib beradi.
- Dakrioadenit va dakriotsistit sababi, klinikasi, davosi va oldini olishni tushuntiradi.
- Chaqaloqlar gonoblenoreyasi va uning oldini olishni aytib beradi.
- Kon’yunktivit turlarini farqlaydi va parvarish qoidalarini sanab beradi.

Tayanch so‘zlar

govmichcha, blefarit, xalazion, qovoq abssessi, dakrioadenit, dakriotsistit, kon’yunktivit, traxoma, gonoblenoreya.

1. Ko‘z qovoqlari kasalliklari

Qovoqlar ko‘zni tashqi ta’sirlardan himoya qiladi va shox parda yuzasini namlab turadi. Ularning terisi yupqa, bezlarga va kipriklarga boy, tashqi muhit bilan doimiy aloqada bo‘lgani uchun yallig‘lanish kasalliklari ko‘p uchraydi. Qovoq kasalliklariga organizm immuniteti pasayishi, qandli diabet, gipovitaminoz, oshqozon-ichak kasalliklari, gijja, kamqonlik, refraksiya anomaliyalari, gigiyena qoidalarining buzilishi, changli va tutunli muhitda ishlash sabab bo‘ladi.

Govmichcha (hordeolum)

Govmichcha kiprik ildizidagi yog‘ bezi yoki soch xaltachasining o‘tkir yiringli yallig‘lanishidir. Qo‘zg‘atuvchisi ko‘pincha stafilokokk. Kasallik uch bosqichda kechadi. Infiltratsiya bosqichida qovoq chetining kichik joyida igna sanchilgandek og‘riq, qizarish va shish paydo bo‘ladi. Yiringlash bosqichida 2–3 kundan keyin og‘riq va shish kuchayadi, uchida yiringli “kallacha” hosil bo‘ladi. So‘rilish bosqichida yiring chiqqach qizarish va shish tez qaytadi, 5–6 kundan keyin izi qolmaydi.

Davosi bosqichga bog‘liq. Infiltratsiya bosqichida 70° li spirt yoki yashil bo‘yoq bilan qovoq cheti surtiladi, quruq issiqlik va UVCh qo‘llaniladi, antiseptik tomchilar va antibiotikli malham buyuriladi. Yiringlash bosqichida isitish, siqish va bog‘lam qo‘yish man etiladi. Govmichchani siqish juda xavfli: yiring qon tomirlar orqali ko‘z kosasi va bosh miyaga tarqalib, qovoq abssessi, flegmona va miya pardalarining yallig‘lanishiga olib kelishi mumkin. Hamshira buni bemorga albatta tushuntiradi. Qaytalanuvchi govmichchada qon va qand tekshiriladi, umumiy davolanish tavsiya etiladi.



Govmichcha: qovoq cheti qizarishi va shishi

Blefarit

Blefarit qovoq qirralarining yallig‘lanishi bo‘lib, ko‘pincha surunkali kechadi. Asosiy shikoyat qovoq qirralarining qattiq qichishi, ko‘z charchashi va achishishi. Uning uch turi bor. Oddiy blefaritda qovoq qirralari qizarib shishadi. Qipiqli blefaritda kipriklar asosida mayda oq qipiqchalar kuzatiladi. Yarali blefaritda kipriklar ildizida sarg‘ish yiring va qatqaloq paydo bo‘ladi, ularni olganda yaralar ochiladi, kipriklar to‘kilishi mumkin. Davolash sababni bartaraf etishdan boshlanadi: refraksiyani tuzatish, surunkali kasalliklarni davolash, ovqatlanishni

yaxshilash. Mahalliy davoda qovoq qirralari tozalanadi, uqalanadi va antibiotikli malham suriladi. Allergik blefaritda qovoq qirralariga gidrokortizon malhami qo‘llaniladi.

Xalazion

Xalazion qovoqning chegaralangan surunkali proliferativ yallig‘lanishi bo‘lib, meybomiy bezi yo‘li yopilishi natijasida hosil bo‘ladi. Tog‘ay ichida tariqdek, keyin no‘xatdek qattiq tugun paydo bo‘ladi. Og‘riq va qizarish yo‘q, bemor uni oynaga qaraganda yoki tekkanda sezib qoladi. Kichik xalazionda shifokor buyurgan malham, issiqlik va UVCh qo‘llaniladi, ba’zan shifokor tugun ichiga dori yuboradi. Katta xalazion poliklinika sharoitida kon’yunktiva tomondan jarrohlik yo‘li bilan olib tashlanadi.

Qovoq abssessi va boshqa holatlar

Qovoq abssessi qovoq to‘qimasida chegaralangan yiringli gazak hosil bo‘lishidir. Qovoq terisi qizaradi, taranglashadi, harorat ko‘tariladi, og‘riq kuchli bo‘ladi. Davolanmasa, 2–3 kunda flegmonaga aylanishi mumkin. Bemor shifokorga darhol yuboriladi: antibiotiklar buyuriladi, yiring yetilganda ochiladi. Qovoqqa qon quyilishi (“ko‘z osti ko‘karishi”) lat yeganda, gemofiliyada va bosh suyagi asosi singanda kuzatiladi. Birinchi yordam: birinchi kun sovuq qo‘yiladi. Ptoz – yuqori qovoq osilishi, lagoftalm – qovoqlarning to‘liq yopilmasligi, entropion – qovoqning ichga, ektropion – tashqiga qayrilishidir. Lagoftalmda shox parda qurishdan himoya qilinadi.

2. Dakrioadenit va dakriotsistit: sabablari, klinikasi, davolash

Ko‘z yoshi a’zolari ko‘z yoshi bezi va ko‘z yoshi yo‘llaridan iborat. Ko‘z yoshi yo‘llariga ko‘z yoshi nuqtalari, naychalari, xaltasi va burun-ko‘z yoshi kanali kiradi. Ularning kasalliklarida bemor ko‘z yoshi oqishidan, yiringli ajralmadan yoki ko‘z burchagidagi shishdan shikoyat qiladi. Ko‘z yoshi yo‘llarining o‘tkazuvchanligi kollargol sinamasi, yuvish, zondlash va rentgenografiya orqali aniqlanadi.

Dakrioadenit

Dakrioadenit ko‘z yoshi bezining yallig‘lanishi bo‘lib, kam uchraydi. U ko‘pincha gripp, angina, epidemik parotit (tepki), ichterlama kabi yuqumli kasalliklarning asorati sifatida rivojlanadi. O‘tkir dakrioadenitda yuqori qovoqning tashqi qismida qizarish, shish va og‘riq paydo bo‘ladi, yuqori qovoq S harfi shaklini oladi, ko‘z olmasi pastga va ichkariga suriladi, harorat ko‘tariladi, quloq oldi limfa tugunlari kattalashadi. Davolash shifokor nazoratida antibiotiklar, yallig‘lanishga qarshi dorilar, quruq issiqlik bilan olib boriladi. Abssess hosil bo‘lsa, ochilib drenaj qo‘yiladi. Asosiy kasallikni davolash muhim.

Surunkali dakriotsistit

Dakriotsistit ko‘z yoshi xaltasining yallig‘lanishidir. U burun-ko‘z yoshi kanalining yopilishi natijasida ko‘z yoshi turib qolishi va mikroblar ko‘payishi oqibatida yuzaga keladi. Sabablari: burun va uning bo‘shliqlarining surunkali kasalliklari, burun shikastlari, polip. Bemor doimiy ko‘z yoshi oqishidan shikoyat qiladi. Ko‘zning ichki burchagida shish, ko‘z yoshi xaltasi sohasini bosganda ko‘z yoshi nuqtalaridan shilimshiq yoki yiring chiqishi kasallikning xarakterli belgisi. Surunkali dakriotsistit shox parda uchun xavfli: kichik jarohat ham yiringli yarani keltirib chiqarishi mumkin, shuning uchun bunday bemorlarga ko‘z operatsiyasi yiring manbai yo‘qotilgunga qadar bajarilmaydi. Asosiy davosi jarrohlik: dakriotsistorinostomiya, ya’ni ko‘z yoshi xaltasi bilan burun bo‘shlig‘i orasida yangi yo‘l hosil qilish.

O‘tkir dakriotsistit va flegmona

O‘tkir dakriotsistit surunkali jarayonning kuchayishi sifatida rivojlanadi. Ko‘z yoshi xaltasi sohasida kuchli qizarish, shish, qattiq og‘riq, harorat ko‘tarilishi kuzatiladi, jarayon flegmonaga aylanishi mumkin. Bu holatda ko‘z yoshi yo‘llarini yuvish va zondlash man etiladi, chunki infeksiya tarqaladi. Bemor shoshilinch shifokorga yuboriladi, antibiotiklar buyuriladi, abssess yetilganda ochiladi.

Chaqaloqlar dakriotsistiti

Ayrim chaqaloqlarda burun-ko‘z yoshi kanali uchidagi embrional parda so‘rilmay qoladi. Hayotning birinchi haftalarida bir ko‘zdan ko‘z yoshi oqishi va shilimshiq-yiringli ajralma paydo bo‘ladi, ko‘z yoshi xaltasini bosganda yiring chiqadi. Hamshira onaga ko‘z yoshi xaltasini yuqoridan pastga massaj qilishni o‘rgatadi: kuniga 3–4 marta, toza qo‘l bilan, ko‘zning ichki burchagidan burun tomon bosib, parda yorilishiga yordam beriladi. Massajdan keyin antiseptik tomchi tomiziladi. Massaj yordam bermasa, shifokor ko‘z yoshi yo‘llarini bosim bilan yuvadi yoki zondlaydi.

Ko‘z yoshi yo‘llarini tekshirish: kollargol sinamasi

Jihozlar: 2–3% kollargol eritmasi, steril pipetka, paxta tampon

1. Bemorga sinama maqsadini tushuntiring.
2. Kon’yunktiva bo‘shlig‘iga 1–2 tomchi kollargol tomizing.
3. Bemor burnini qoqmasdan o‘tirsin, ko‘zni pirpiratsin.
4. Ko‘zdagi bo‘yoq 5 daqiqagacha yo‘qolsa, so‘rilish normal.
5. Burun yo‘liga tampon kiritib, 5 daqiqa ichida bo‘yalishini tekshiring: bo‘yalsa, yo‘l o‘tkazuvchan.

Hamshira ko‘z yoshi oqishidan shikoyat qilgan bemorni diqqat bilan so‘raydi: u faqat sovuqda va shamolda kuchayadimi yoki doimiymi, yiringli ajralma bormi, ko‘z yoshi bir tomonlamami. Keksa bemorlarda ko‘z yoshi nuqtasining qovoqdan ajralib qolishi ham ko‘z yoshi oqishiga sabab bo‘ladi. Dakriotsistitli

bemorga ko‘z yoshi xaltasi sohasini o‘zi bosmaslik, shifokor ko‘rsatgan tomchilarni tomizish va burun kasalliklarini davolash tushuntiriladi.

3. Kon’yunktivitlar: sabablari, turlari, belgilari va oldini olish

Kon’yunktiva normada yaltiroq, silliq, och pushti rangda. Unda yallig‘lanish, distrofiya, tug‘ma kasalliklar, o‘smalar va shikastlanishlar bo‘lishi mumkin, ammo eng ko‘p uchraydigani yallig‘lanish, ya’ni kon’yunktivit. Kon’yunktivit o‘tkir va surunkali, kelib chiqishi bo‘yicha bakterial, virusli, allergik va xlamidiyali turlarga bo‘linadi. Umumiy belgilari: ko‘z qizarishi, achishish, “ko‘zga qum tushgandek” sezgi, ko‘z yoshlanishi va ajralma. Odatda ko‘rish pasaymaydi, shox parda zararlanganda esa pasayadi.

Turi	Qo‘zg‘atuvchi	Xos belgilar
Bakterial	Stafilokokk, streptokokk, pnevmokokk, Koks–Uiks tayoqchasi	Yiringli ajralma, ertalab kipriklar yopishadi, ko‘pincha ikki ko‘zda
Virusli	Adenovirus, gerpes virusi	Suvsimon ajralma, follikulalar, isitma, faringit, quloq oldi limfa tuguni kattalashadi, juda tez yuqadi
Allergik	Dori, kosmetika, gulchang, chang	Kuchli qichish, qovoq shishi, ikki tomonlama, shilimshiq ajralma
Surunkali	Chang, tutun, oftob, shamol, refraksiya nuqsoni	Yengil qizarish, achishish, charchash, uzoq kechish

O‘tkir bakterial kon’yunktivit

Kasallik to‘satdan boshlanadi, avval bir, keyin ikkinchi ko‘zda rivojlanadi. Epidemik (Koks–Uiks) kon’yunktivit tez tarqaladi va kon’yunktivaga nuqtali qon quyilishlar bilan kechadi. Difteriyali kon’yunktivit og‘ir kechadi, kon’yunktivada kulrang qiyin ajraladigan parda hosil bo‘ladi. Davolashda ko‘z antiseptik eritmalar bilan yuviladi, kuniga bir necha marta antibiotikli tomchilar (0,25% levomitsetin, 20–30% albutsid va boshqalar) tomiziladi, kechasi malham qo‘yiladi. O‘tkir kon’yunktivitda bog‘lam qo‘yish mumkin emas: bog‘lam ostida ajralma to‘planadi, harorat oshadi va mikroblar ko‘payadi.

Gonokokkli kon’yunktivit va gonoblenoreya

Gonoblenoreyani Neysser gonokokki keltirib chiqaradi. Chaqaloqlarda kasallik tug‘ruq paytida onadan yuqadi va hayotning 2–3-kunlarida boshlanadi. Qovoqlar qattiq shishadi, ko‘p miqdorda yiring ajraladi, shox parda yarasi va ko‘rlik xavfi yuqori. Oldini olish uchun tug‘ruqxonada barcha chaqaloqlarning ko‘zi tug‘ilgan zahoti shifokor belgilagan antiseptik eritma bilan ishlanadi, homilador ayollar tekshiriladi. Bunday bemor ajratib davolanadi, hamshira himoya ko‘zoynagi va qo‘lqopda ishlaydi, chunki infeksiya o‘ziga ham yuqishi mumkin.

Virusli kon’yunktivit va traxoma

Adenovirusli kon’yunktivit isitma, faringit va yiringsiz follikulyar kon’yunktivit bilan kechadi, bolalar jamoalarida tez tarqaladi. Gerpetik kon’yunktivit ko‘pincha bir ko‘zda, qovoq terisida pufakchalar bilan uchraydi. Davolashda virusga qarshi tomchilar va malhamlar qo‘llaniladi. Traxoma xlamidiyalar keltirib chiqaradigan kon’yunktiva va shox pardaning surunkali yuqumli yallig‘lanishidir. U chandiqlar, trixiaz va ko‘rlikka olib keladi. O‘zbekistonda u ommaviy kasallik sifatida tugatilgan, lekin hamshira uning belgilarini bilishi kerak.

Hamshiralik parvarishi va profilaktika

- Har bir bemorga alohida sochiq, tomchi va tampon ajratish; qo‘lni tez-tez yuvish.
- Ko‘zni ichki burchakdan tashqi burchakka qarab yuvish.
- Ajralma tozalangandan keyin dori tomizish, kuniga 6–8 marta va undan ko‘p.
- Bog‘lam qo‘ymaslik, quyoshdan himoya ko‘zoynagi tavsiya qilish.
- Bolalar jamoasida kasal bolani ajratish, asboblarni dezinfeksiya qilish.
- Kontakt linzani kasallik davrida taqmaslik, kosmetikadan vaqtincha voz kechish.

Pterigium va bahor katari

Pterigium kon’yunktivaning uchburchak shaklida shox parda ustiga o‘sishi bo‘lib, shamol, chang va quyosh nuri ko‘p ta’sir qiladigan hududlarda uchraydi. U ko‘z ichki burchagi tomonidan boshlanadi. Shox parda markaziga yetsa, ko‘rishni pasaytiradi va jarrohlik yo‘li bilan olib tashlanadi. Quyoshdan himoya ko‘zoynagi taqish uning rivojlanishini sekinlashtiradi. Bahor katari allergik kasallik bo‘lib, bahor va yozda kuchayadi, kuchli qichish bilan kechadi va asosan o‘g‘il bolalarda uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva F. S., Yusupova M. S., Aripova S. M. Ko‘z kasalliklari. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2007.
2. Po‘latova Sh. A., Aripova G. S., Mirzajonova G. X. va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi. II qism. – Toshkent, 2012.
3. Bikbov M. M. va boshq. Oftalmologiya: darslik (rus tilida). – Moskva: GEOTAR-Media, 2019.
4. World Health Organization. World report on vision. – Geneva: WHO, 2019.